

지역사회기반 의학교육과정 개발 및 적용

1차년도 성과 정리본 · 2025~2026

지역사회와 공공의료 현장을 배움의 공간으로 연결하기 위해 공통 운영 체크리스트와 네 가지 교육과정 모형을 개발하고, 대학별 적용을 위한 사례 조사와 상호 컨설팅을 진행했습니다.

홈페이지에 공개된 주요 결과와 세부 성과를 모은 자료입니다. 원본 보고서와 구분됩니다.

핵심 성과

4종 · 교육과정 운영 모형

9개 영역 · 표준 체크리스트

18건 · 교육과정 사례 조사

- 지역사회 실습 운영 표준 체크리스트 v1.0을 개발·공개했습니다. 운영 기반 구축, 구조화된 실습, 학생 지원의 세 원리에 따라 9개 영역을 점검하도록 구성했습니다.
- 통합 로테이션형, 지역사회보건·건강문제 해결형, 공공병원 임상몰입형, 개원가 중심형의 네 모형을 정립했습니다. 교육목표·실습장·학습경험·학생 산출물·평가·운영 지원의 6차원 비교 틀을 마련했습니다.
- 공통 양식으로 교육과정 사례 18건을 수집했습니다. 필수 교과 10건, 선택 교과 6건, 비교과 2건이며 학점을 부여하는 사례는 13건입니다. 모형은 복수 선택 방식으로 분류했습니다.
- 워크숍 2회, 연구회의 6회, 실무진 회의 12회를 운영했습니다. 두 번째 워크숍에서는 모형별 소그룹 토의와 상호 컨설팅으로 대학별 실행 계획을 구체화했습니다.
- 국립중앙의료원과 2026년 1월 9일 협약을 체결하고, 지역사회 실습·교수개발·코디네이터 협력의 기반을 마련했습니다. 성과공유세미나 발표는 3회 진행했습니다.
- 산출물 7종을 개발·관리했습니다. 체크리스트·모형 정의서·분석 틀·워크시트는 완료했으며, 표준 산출물 패키지는 전략 확정 후 개발 중입니다. 가이드라인·평가 루브릭과 사례 자료집 편집도 진행 단계입니다.

- 1차년도는 모형 개발·사례 조사·컨설팅 단계입니다. 신규 모형의 시범운영과 정량적 타당화, 학생 평가·만족도 분석은 후속 과제로 연결됩니다.

참여 대학 수는 요약 집계와 개별 대학 목록이 일치하지 않아 확인 중입니다. 사례 분포는 18건 기준이며 모형별 건수는 복수 선택으로 중복됩니다.

주요 산출물

- 표준 체크리스트 v1.0
- 4개 운영 모형 정의서
- 6차원 비교·분석 틀
- 공통 코어+모형별 옵션 개발 전략
- 모형별 맞춤형 워크시트
- 표준 가이드라인·평가 루브릭 초안
- 교육과정 사례 조사 자료집

세부 성과 목차

- 01 · 추진 배경 및 이론적 배경
- 02 · 과제 목표 및 성과지표
- 03 · 추진 체계 및 방법
- 04 · 추진 경과 및 실적
- 05 · 주요 결과 및 성과물
- 06 · 성과지표 달성도 및 자체평가
- 07 · 성과 확산 및 활용 방안
- 08 · 추진 과정의 쟁점·애로사항 및 개선 방안

09 · 지역사회 실습 운영 체크리스트 개발 결과

10 · 교육과정 운영 모형·그림과 설계 기준

01 추진 배경 및 이론적 배경

1. 추진 배경 및 필요성

☐ 정책·제도적 배경

○ 지역·필수의료 위기 대응과 통합 6년제 전환 등 의학교육 여건 변화 속에서, 지역사회 기반 교육과정 개발은 국가 의학교육 혁신사업의 핵심 과제 중 하나로 재확인됨

○ 의료법 시행규칙 제19조는 의과대학 학생의 의료행위를 지도교수 또는 의료인의 지도·감독하에 허용하고 있어, 지역사회 실습에서 의료진의 책임 있는 지도 참여가 법적·제도적으로 요구됨

☐ 의학교육 현장의 문제 인식

○ 지역사회 실습이 대학별로 산발적으로 운영되어 전국 공통의 운영 기준·표준 자료가 부재하고, 기관 간 실습 질의 편차가 큼

○ 지역 실습 인프라 부족, 자율참여의 한계, 실습기관의 소극적 태도 등 실행 장벽이 존재함

☐ 본 과제가 해결하고자 한 구체적 문제(problem statement)

○ "전국 의과대학이 지역사회 실습을 안정적·지속적으로 운영하기 위해 공통으로 점검해야 할 요소는 무엇이며, 대학별 여건 차이를 수용할 수 있는 교육과정 운영 모형은 어떻게 유형화할 수 있는가"

2. 주요 개념 및 용어 정의

용어	정의	출처
지역사회기반 의학교육(CBME)	학습이 병원 중심을 넘어 보건소·공공의료기관·지역사회 기관 등 지역사회 현장에서 이루어지는 교육 접근	WHO(1987) 등
LIC(종적통합실습)	학생이 일정 기간 동일 지역·기관에서 환자·지도자와의 연속적 관계 속에 여러 전공 역량을 통합적으로 학습하는 실습 모형	Worley 등(2016)
SDOH(건강의 사회적 결정요인)	개인·인구집단의 건강에 영향을 미치는 사회·경제·환경적 조건	WHO
권역책임의료기관	권역 내 공공보건의로 협력체계의 중심 역할을 수행하도록 지정된 의료기관으로, 본 과제에서 주요 실습 협력기관	보건복지부
Mini-CEX	실제 진료 장면을 직접 관찰하여 임상수행을 평가·피드백하는 직접관찰평가 도구	Norcini 등(2003)

3. 선행연구 및 문헌 고찰

- 문헌 검토 방법 및 범위: 지역사회기반 의학교육, 농어촌·공공의료 실습, LIC 관련 국내외 문헌과 KAMC 선행 TF·컨소시엄 산출물을 검토하여 체크리스트 영역 및 모형 설계의 근거로 활용함
- 주요 이론·모형: 지역사회기반 교육(CBME), 종적통합실습(LIC), 사회적 책무성(social accountability), 직장기반 평가(Mini-CEX 등 WBA)를 설계 근거로 삼음
- 선행연구의 한계와 본 과제의 차별성: 기존 국내 연구는 개별 대학 단위의 운영 경험 보고에 집중되어 있어, 전국 공통 운영 체계(체크리스트)와 유형화된 운영 모형을 함께 제시한 본 과제와 차별화됨

4. 국내외 사례 분석

구분	기관·대학(국가)	주요 운영 내용	시사점
국내	강원대학교 의과대학	도내 공공의료원·보건소 연계 1주 단위 순환 실습, 기숙사·ZOOM 일일 점검 등 원거리 지원, '지역공공보건의료 실습' 학점화	원거리 실습 지원체계와 학점화가 핵심 성공요인
국내	동국대학교 의과대학	경상북도 도비 3천만 원 확보, 포항의료원 등 3개 공공의료원 1주 실습, 지도의사 수당 지급	지자체 주도 톱다운 방식의 실효성 확인
국외	호주 Rural Clinical School / 캐나다 NOSM / 일본 지치의대 등	농어촌·지역 장기 몰입형 실습과 지역사회 밀착형 교육과정 운영	장기 몰입·지역 정주 연계 설계의 시사점

5. 시사점 및 과제 설계 방향

도출된 시사점	과제 설계 반영 내용
① 실습 운영의 안정성은 네트워크·MOU 등 제도적 기반의 선행 구축에 달려 있음	체크리스트를 '운영 기반 선행 구축 → 구조화된 실습 운영 → 학생 지원'의 3대 구성원리로 설계
② 대학별 지역 여건·교육 목표의 차이가 커서 단일 표준 모형으로는 수용 불가	4개 운영 모형으로 유형화하되 혼합 적용을 허용하고, 6차원 분석 프레임으로 모형 간 차이를 정의
③ 지도 의료진의 참여·보상이 실습 질의 관건	외적·내적 동기부여 방안(성과평가 지표 반영, 인센티브)을 체크리스트에 명시, '지도교수 부담을 최소화한 현실적 평가도구 개발'을 공동 과제로 추진
④ 산출물의 중복 개발을 막고 효율성을 높일 필요	4종 산출물을 공통 코어(Common Core)+모델별 옵션(Model Option)의 이원 구조로 개발

02 과제 목표 및 성과지표

1. 최종 목표 및 1차년도 목표

최종 목표 (사업 종료 시점)	전국 의과대학이 공동 활용하는 지역사회기반 의학교육과정 운영 체계(체크리스트·운영 모형·표준 산출물 패키지)를 완성하고, 대학별 학사과정 반영과 전국 실습 네트워크(NMC 연계)를 통해 지속 가능한 운영 기반을 확립
1차년도 목표	① 지역사회 실습 운영 표준 체크리스트 개발·공개 ② 교육과정 운영 모형 유형화 및 정의 확정 ③ 선도 사례 정리 및 워크숍 기반 대학별 적용 컨설팅 ④ 정책 제안·협력 네트워크(NMC MOU) 기반 구축
과제 범위 (포함·제외)	포함: 운영 체계·모형·표준 자료 개발, 사례 공유·컨설팅, 정책 연계 / 제외: 개별 대학의 학사 승인 절차, 실습기관과의 개별 계약 체결(대학 소관)

2. 성과지표 및 목표치

연번	성과지표명	유형	산출식·측정 방법	목표	실적	달성률(%)
1	지역사회 실습 운영 표준 체크리스트 개발	정량	개발 산출물 수(종)	미확정	1종(9개 영역)	-
2	교육과정 운영 모형 개발	정량	정의 확정 모형 수(종)	미확정	4종	-
3	전체 워크숍 개최	정량	개최 횟수(회)	미확정	2회	-
4	연구·실무 회의 운영	정량	개최 횟수(회)	미확정	18회(연구 6, 실무 12)	-
5	성과 확산(세미나 발표 등)	정량	발표·공유 건수(건)	미확정	4건(세미나 3, 학술대회 1)	-
6	협력 기반 구축(MOU 등)	정성	협약 체결·정책 제안 실적	미확정	NMC MOU 1건, 정책 제안 4건	-
7	대학별 교육과정 사례 조사	정량	사례 수집 대학·건수	미확정	12개교 18건	-

03 추진 체계 및 방법

1. 추진 체계 및 조직

□ 운영팀(기획팀)-실행팀-간사의 3층 구조로 운영하며, 전체회의(워크숍)와 실무회의를 구분하여 개최함

조직·회의체	구성(인원)	주요 기능 및 개최 주기
운영팀(기획팀) 회의	운영팀 교수 7인 + 간사	교육과정 개발·적용의 전체 운영·설계, 체크리스트·모형 확정, 워크숍 기획 / 총 6회(연구회의)
실행팀(전체 워크숍)	전국 의과대학 실무 담당 교수	사례 공유, 상호 컨설팅, 산출물 검토·환류 / 총 2회
간사·실무진 회의	간사(안준무) 및 실무진	회의 간 실무 조율, 자료 취합·배포(체크리스트 엑셀화 등), 대학별 개별 연락·참여 독려 / 총 12회
대외 협력 회의	운영팀·KAMC 사무국·NMC 등	국립중앙의료원 간담회·MOU, 보건복지부 정책 제안 / 수시

2. 참여 대학·기관 현황

연번	대학·기관명	참여 형태	담당자	비고
1	단국대·인제대·경상국립대·강원대·인하대·동국대·서울대 의과대학	공동개발(운영팀)	운영팀 명단 참조	과제 설계·운영
2	전국 의과대학 실행팀	공동개발·사례 제공	실행팀 위원 27명	전국 26개 의과대학·기관(I 장 2절 명단 참조)
3	부울경 컨소시엄(부산·울산·경남 5개교)	사례 제공·컨설팅	서지현·임선주	권역 협력 모델
5	보건복지부·지자체·공공의료기관	정책 협의·실습 협력	-	4대 정책 제안 전달

3. 연구·개발 방법

방법	대상·표본	실시 시기	분석 방법·활용
문헌고찰	CBME·LIC·공공의료 실습 관련 문헌, KAMC 선행 산출물	2025. 8.~	체크리스트 영역·모형 설계 근거 도출
설문조사	실행팀 대상 워크숍 참석·모델 선호 수요조사(단체대화방 투표)	2026. 2.	모델별 소그룹 인원 배분·워크시트 설계
FGI·FGD	해당 없음(워크숍 내 그룹토의로 갈음)	-	-
델파이 조사	해당 없음(2차년도 타당화 시 검토)	-	-
워크숍·합의회의	운영팀 회의 6회, 전체 워크숍 2회(전국 실행팀)	2025. 9.~2026. 3.	체크리스트 전원 합의, 4개 모델·명칭 확정, 4대 공통 이슈 도출(참석자 전원 합의)
사례조사	강원대·동국대·부울경 컨소시엄 운영 사례	2025. 12.~	모형 유형화 및 6차원 프레임의 실증 근거
시범운영	1차년도 해당 없음(2차년도 Pilot 예정: 성과지표 포함)	2026년 하반기~	모델 적용 대학 시범운영·성과지표 Pilot

4. 연구윤리

IRB 심의 여부	☐ 승인(기관: , 승인번호:) ☐ 심의면제 ☒ 해당없음(교육과정 운영 체계 개발 과제로 인간대상연구 미포함)
저작권·초상권 확인	발표자료·사례 자료는 제공 대학의 동의 하에 활용하며, 산출물 저작권 귀속은 VI장 7절에 기재함

5. 추진 일정

단계	기간	주요 활동	단계별 산출물
1단계	2025. 7.~9.	킵오프(전국 27개교), 연구팀 구성, KAMC 역할 정의, 1차 기획 팀 회의	KAMC 5대 역할 체계, 향후 계획(안)
2단계	2025. 10.~11.	운영팀·실행팀 구성, 체크리스트(안) 검토·합의, KAMC 학술대회 초안 공개	운영·실행팀 체계, 체크리스트 초안
3단계	2025. 12.	실행팀 전체 워크숍(1차): 체크리스트·선도 사례 공유, 공통 이슈 도출	체크리스트 v1.0, 4대 공통 이슈
4단계	2026. 1.~2.	NMC MOU 체결, 모델 정립·명명, 6차원 프레임·산출물 패키지 전략, 워크숍 설계	4개 모델 정의서, 모델별 워크시트
5단계	2026. 3.~8.	2차 전체 워크숍(모델별 컨설팅), 리더십 워크숍 연계, 성과공유세미나 발표, 최종보고	대학별 실행 계획안, 최종보고서

04 추진 경과 및 실적

1. 단계별 추진 경과

□ 착수(2025. 7.~9.): KAMC 역할 합의

○ 킥오프 미팅(7. 30., 서울의대, 전국 27개교 위원 참석)에서 'adapted expertise' 역량을 기본 방침으로 안내하고, 정책 연계·교수개발 및 자료 아카이브·성과관리·중앙 매칭 시스템·관리자 역량 강화의 KAMC 5대 역할을 도출함

○ 장·단기 계획 병행의 필요성(단기 성과 없이는 다년 과제 전환이 어려움)에 합의하고 수정 계획서 제출·분석 절차를 확정함

□ 체계 구축(2025. 10.~11.): 운영·실행 이원 체계와 체크리스트 합의

○ 2차 기획팀 회의(10. 25.)에서 기획팀을 운영팀으로 전환하고, 전국 실무 담당자로 실행팀을 구성(공문 발송, KAMC 사무국 주관)하기로 확정함

○ 장지은 교수가 정리한 지역사회 실습 운영 체크리스트 초안에 운영팀 전원이 동의하고, 군병원·경찰병원 등 실습기관 후보 확대와 지자체 보건행정 책임자 네트워크 포함(부산·경남 사례)을 결정함

○ KAMC 학술대회(11. 14.)에서 체크리스트 초안을 공개함

□ 공유·확산(2025. 12.): 1차 전체 워크숍

○ 실행팀 전체 워크숍(12. 3., 하이브리드)에서 체크리스트 개발 내용(장지은), 강원대의대(강석훈)·동국의대(유석주)·부울경 컨소시엄(서지현) 사례를 발표하고, 지도교수 인센티브·평가체계·네트워크 강화·자료 표준화의 4대 핵심 공통 이슈를 참석자 전원 합의로 도출함

○ 실행팀 간 '정기 네트워크 운영'과 '지도교수 부담을 최소화한 현실적 평가도구 개발' 추진에 합의함

□ 모형 정립(2026. 1.~2.): 4개 모델 체계 확정

○ NMC MOU 체결(1. 9.) 후 기획팀 회의(1. 30.)에서 3개 모델(안)을 유형화하고, 형식적 차이가 아닌 '핵심 가치와 기능'이 드러나는 국·영문 명칭과 정의, 6차원 구조적 차이 분석 프레임, 공통 코어+모델별 옵션의 표준 산출물 패키지 전략, NMC MOU 3단계 협력 범위를 확정함

○ 운영팀 회의(2. 26.)에서 개원가(일차의료) 중심형을 추가한 4개 모델 체계로 확장하고, 2차 워크숍을 발표형이 아닌 모델별 소그룹 테이블 토의형으로 운영하기로 결정함. 간사가 체크리스트를 엑셀로 정리·공유하고 퍼실리테이터별 모델 맞춤형 워크시트를 개발함

□ 적용·컨설팅(2026. 3.~4.): 2차 워크숍과 리더십 연계

- 2차 전체 워크숍(3. 6.)을 모델별 소그룹 토의형으로 운영하여 각 대학의 계획안·운영안에 대해 운영 경험 교수(퍼실리테이터)가 직접 피드백하는 상호 컨설팅을 수행하고, 대학별 수업계획서·실행 계획안 도출을 목표로 진행함
- 리더십 워크숍(4. 9.~10., 경주) 학장단 세션에서 4개 모델과 워크숍 결과물을 소개함

2. 회의·워크숍·세미나 개최 실적

가. 개최 실적 총괄

전체 워크숍	2회	미확정	체크리스트·사례 공유(1차), 모델별 컨설팅(2차)	전국 실행팀
연구회의(전문가 회의)	6회	미확정	체크리스트·모형 설계 및 의사결정	운영팀
실무진 회의	12회	미확정	자료 취합·배포, 워크시트 제작, 참여 독려	간사 주관
세미나·설명회	4회	461명(세미나 3회 합산)	성과공유세미나 발표(3회), KAMC 학술대회(1회)	KAMC 주최
합 계	24회	-	-	-

나. 회차별 세부 실적(주요 회의)

연번	구분	일자	장소	주요 안건	논의·결정 사항
1	kick-off	2025. 7. 30.	서울의대 융합관	연구 기대성과·기본 방침, KAMC 역할	KAMC 5대 역할 도출, 수정 계획서 제출 절차 확정
2	연구회의	2025. 9. 27.	온라인	1차 기획팀 회의	추진 방향·역할 분담
3	연구회의	2025. 10. 25.	온라인 Zoom	운영·실행팀 구성, 체크리스트(안) 검토	운영팀 전원 체크리스트 동의, 실행팀 공문 구성 확정
4	세미나	2025. 11. 14.	KAMC 학술대회	체크리스트 초안 공개	전국 공개 및 의견 수렴
5	워크숍(1차)	2025. 12. 3.	하이브리드	체크리스트 발표, 강원·동국·부울경 사례	4대 공통 이슈 전원 합의, 정기 네트워크 운영 합의
6	대외 협력	2026. 1. 9.	NMC	협력 MOU	MOU 체결(공공의료 실습·교수개발·코디네이터)
7	연구회의	2026. 1. 30.	온라인 Zoom	모델 비교·명명, 6차원 프레임, 산출물 패키지, MOU 범위	모델 정의·명칭 확정, 공통 코어+옵션 전략·3단계 MOU 옵션 확정
8	연구회의	2026. 2. 26.	온라인 Zoom	2차 워크숍 운영 방안	4개 모델·소그룹 토의형 확정, 퍼실리테이터 배정, 워크시트 공유 일정 확정
9	워크숍(2차)	2026. 3. 6.	미확정	모델별 소그룹 테이블 토의	대학별 계획안 상호 컨설팅, 실행 계획 구체화
10	연계 행사	2026. 4. 9.~10.	경주	리더십 워크숍 학장단 세션	4개 모델 소개·질의응답

※ 기타 연구회의(2회) 및 실무진 회의(12회)의 세부 내역은 부록 2에 이관함

3. 조사·시범운영 추진 실적

구분	대상	규모(N)	실시 결과 요약
워크숍 수요조사	전국 실행팀(모델별 참석 희망)	미확정	4개 모델별 참석 인원 배분, 미참여 대학 개별 연락으로 참여 독려
대학별 교육과정 사례 조사	학술대회 사례 공유·모델별 비교를 위한 공통 양식(기본 정보-모델 선택-핵심 구성-운영 포인트·지원 필요)으로 전국 의과대학 대상 조사	12개교 18건	전 학년(예과 1~의학과 5학년)에 걸친 사례 확보, 4개 모델 전체와 자체 확장 모델 6건 수집, 제3회 성과공유세미나에서 공유
시범운영	해당 없음(2차년도 성과지표 Pilot 및 모델 적용 시범운영 예정)	-	-

4. 계획 대비 변경사항 및 사유

변경 항목	당초 계획	변경 내용	변경 사유
운영 모형 수	3개 모델(안) 유형화(2026. 1. 30. 합의)	지역사회 개원가(일차의료) 중심형을 추가한 4개 모델 체계	1차 의료기관·개원가 연계 실습 수요와 실제 운영 사례 반영 필요
2차 워크숍 운영 방식	전체 발표형	모델별 소그룹 테이블 토의형	단순 설명보다 대학별 계획안에 대한 직접 피드백·상호 컨설팅이 적절하다는 운영팀 합의

05 주요 결과 및 성과물

교육과정 사례는 18건입니다. 참여 대학 수는 집계와 개별 목록의 차이를 확인 중입니다.

1. 핵심 결과 요약

- ① 지역사회 실습 운영 표준 체크리스트를 9개 핵심 영역으로 확정하고 전국에 공개하였다.
- ② 지역사회기반 교육과정 운영 모형을 4개 유형(통합 로테이션형, 지역사회보건 해결형, 공공병원 임상몰입형, 개원가 중심형)으로 정립하고 국·영문 명칭과 정의, 6차원 구조적 차이 분석 프레임을 확정하였다.
- ③ 학생·교수 가이드북, 교육과정안, FD 프로그램의 4종 산출물을 공통 코어+모델별 옵션의 이원 구조로 개발하는 표준 산출물 패키지 전략과 운영 자료(표준 가이드라인·평가 루브릭 초안, 모델별 워크시트)를 마련하였다.
- ④ 선도 사례 3건(강원의대·동국의대·부울경)을 모형 관점에서 정리하고, 워크숍 기반 상호 컨설팅으로 대학별 실행 계획 수립을 지원하였다.
- ⑤ 공통 양식 기반 대학별 교육과정 사례 조사를 통해 12개 대학 18건의 지역사회기반 교육과정을 4개 모델 체계로 수집·분석하고, 모든 모델에서 실제 운영 사례가 확인되어 모형 체계의 현장 타당성을 검증하였다.
- ⑥ 보건복지부 4대 정책 제안 전달과 NMC MOU 체결(3단계 협력 프레임)로 전국 실습 네트워크의 정책·협력 기반을 구축하였다.

2. 산출물 총괄표

연번	산출물명	유형	규격·분량	완료 시점	완료 여부	첨부 위치
1	지역사회 실습 운영 프로그램 표준 체크리스트 v1.0	표준양식·서식	9개 영역, 14면	2025. 12.	완료	부록 1
2	교육과정 운영 모형 정의서(4종: 국·영문 명칭+정의, 비교표)	역량·성과 체계(프레임)	4개 모델 × 5개 비교 항목	2026. 3.	완료	부록 1
3	구조적 차이 분석 프레임(6 Dimensions)	역량·성과 체계(프레임)	6개 차원 × 3개 하위요소	2026. 1.	완료	부록 1
4	표준 산출물 패키지 개발 전략(공통 코어+모델별 옵션)	교육과정 편성안	4종 산출물 목차 체계	2026. 1.	전략 완료(개발 진행 중)	부록 1
5	모델별 맞춤형 워크시트(엑셀)	표준양식·서식	4개 모델별 각 1식	2026. 3.	완료	부록 1
6	표준 가이드라인·평가 루브릭 초안	평가도구·루브릭	미확정	2026. 8.(예정)	진행 중	부록 1
7	대학별 교육과정 사례 조사 자료집(공통 양식 기반)	사례집·조사보고서	12개 대학 18건	2026. 5.	조사 완료(자료집 편집 중)	부록 5

3. 산출물별 상세 내용

산출물 1. 지역사회 실습 운영 프로그램 표준 체크리스트 v1.0

산출물명	지역사회 실습 운영 프로그램 표준 체크리스트 v1.0 (개발 주관: 동국의대 예방의학교실 장지은)
개발 목적·활용 대상	지역사회 실습의 체계적 운영을 위해 실습 기반 조성-운영-학생 지원·안전관리 전 과정에서 필수 점검 요소를 제공. 전국 의과대학 실습 담당 교수·행정 담당자 대상
개발 절차	초안 작성(장지은, 2025. 10.) → 운영팀 전원 검토·동의(10. 25.) → KAMC 학술대회 공개·의견 수렴(11. 14.) → 전체 워크숍 발표·환류(12. 3.) → v1.0 확정 → 모델별 맞춤형 워크시트로 확장(2026. 2.~3.)
주요 구성·목차	3대 구성원리(① 운영 기반 선행 구축 ② 구조화된 실습 운영 ③ 학생 중심 지원 체계) 하에 9개 영역: 1) 지역자원 개발 2) 연계체계 구축 3) 의료진·담당자 참여 4) 실습 운영 방향 5) 교과목 운영 방향 6) 실습 운영 방안 7) 학생 생활지원 8) 학생 모니터링 9) 학생 안전관리(보험·위험관리 필수)
타당화·검증 근거	운영팀 전원 합의(2025. 10. 25.), 전국 실행팀 워크숍 검토·환류(2025. 12. 3.), 선도 3개 사례와의 정합성 확인. 정량적 타당화(델파이 등)는 2차년도에 추진
활용 방법 및 배포 계획	대학별 맞춤형 변형이 가능한 활용 가이드와 함께 배포. 모델별 특성에 따라 항목을 가감한 엑셀 워크시트 형태로 2차 워크숍에 적용하였으며, KAMC 자료 아카이브(공동 드라이브)를 통해 공유
한계 및 보완 필요사항	현장 적용 데이터 기반의 항목별 중요도·실행가능성 검증 필요(2차년도 Pilot 연계)

산출물 2. 교육과정 운영 모형(4종) 및 6차원 분석 프레임

산출물명	지역사회기반 교육과정 운영 모형 정의서(4종) 및 구조적 차이 분석 프레임(6 Dimensions)
개발 목적·활용 대상	대학별 지역 여건·교육 목표에 따라 선택·혼합 적용 가능한 유형화된 운영 모형 제공. 각 대학 교육과정 설계 책임자·학장단 대상
개발 절차	선도 사례 분석(2025. 12.) → 3개 모델(안) 유형화·명명 원칙 합의(2026. 1. 30.: '형식적 차이'가 아닌 '핵심 가치와 기능' 중심 명명, 국·영문 명+1문장 정의 필수) → 개원가형 추가로 4개 모델 확정(2026. 2. 26.) → 2차 워크숍 모델별 컨설팅 적용(3. 6.)
주요 구성·목차	Model 1 지역기반 통합 로테이션형(Community-Integrated Rotation Model), Model 2 지역사회보건·건강문제 해결형(Community Health & Population Model), Model 3 지역공공병원 임상몰입형(Public Hospital Immersion Model), Model 4 지역사회 개원가(일차의료) 중심형. 각 모델은 핵심 포커스·실습장 구성·주요 학습경험·대표 산출물·운영 포인트의 5개 항목으로 비교 기술. 6차원 프레임: ① 교육목표(LO) ② 실습장(기관) 구성 ③ 핵심 학습경험 ④ 학생 산출물 ⑤ 평가체계 ⑥ 운영·지원 요건
타당화·검증 근거	실제 운영 사례 3건과의 대응 검증, 교육과정 개발 위원회 안건 상정·의결(2026. 1. 30.), 2차 워크숍 참여 대학의 적용 검토
활용 방법 및 배포 계획	각 대학이 6차원 프레임으로 자체 여건을 진단한 뒤 모델을 선택·혼합 적용하도록 안내. 모델별 워크시트·표준 산출물 패키지와 연동하여 배포
한계 및 보완 필요사항	모델 2는 예방의학·지역사회보건 교육과정에 이미 내재된 경우가 많아 표준화보다 사례집 축적·공유 방식이 적합(예방의학회 협력 검토), 모델 4는 협약·비용 지원·현장 운영 등 실무 디테일 축적 필요

산출물 3. 표준 산출물 패키지 개발 전략(공통 코어 + 모델별 옵션)

산출물명	표준 산출물 패키지 개발 전략(학생 가이드북, 교수(지도자) 가이드북, 임상실습 교육과정(안), 교수개발(FD) 프로그램)
개발 목적·활용 대상	4종 산출물의 중복 개발을 방지하고 모델 간 일관성을 확보하기 위한 이원화 개발 체계. 산출물 집필진·참여 대학 대상
주요 구성·목차	공통 코어: 실습 목적·역량(LO)·행동규범·안전·평가 구조(학생), 지도자 역할·평가 루브릭·코칭 가이드(교수), 표준 1페이지 구조(목표·경험·과제·평가)의 교육과정안, OT·루브릭 채점 실습·기본 코칭 스킬(FD) / 모델별 옵션: 보건기획 템플릿(2안), 임상 필수경험 체크리스트(3안), 다기관 연속성·핸드오버 지침(1안), 트랙별 심화 FD 등
활용 방법 및 배포 계획	공통 목차(코어 항목 7~10개)를 확정하고 작성자·검토자 지정 및 마감 관리 체계로 2차년도에 개발 완료 예정
한계 및 보완 필요사항	1차년도는 전략·목차 수준으로 확정, 본문 집필은 2차년도 추진

산출물 4. 대학별 교육과정 사례 조사 자료집(공통 양식 기반, 12개 대학 18건)

산출물명	대학별 지역사회기반 교육과정 사례 조사 자료집(학술대회 사례 공유 및 모델별 비교를 위한 공통 양식 기반)
개발 목적·활용 대상	4개 모델 체계의 현장 타당성을 검증하고 대학 간 벤치마킹이 가능한 표준화된 사례 데이터를 축적. 전국 의과대학 교육과정 설계자·실습 담당 교수 대상
개발 절차	공통 양식 설계(① 기본 정보 ② 교육과정 모델 선택 ③ 핵심 구성: 핵심 포커스·실습/학습 구조·주요 학습경험·대표 산출물·평가 방법 ④ 운영 포인트 및 지원 필요: 연계 기관·고려사항·필요 지원·확산 가능성) → 전국 대학 배포·수합 → 12개교 18건 취합 → 모델별 분석 → 제3회 성과공유세미나(2026. 5. 15.) 공유
참여 대학(12개교, 18건)	가천의대, 강원대의대, 건국대의대, 경상국립대의대, 대구가톨릭대의대, 동국대의대, 성균관대의대, 순천향대의대, 아주의대, 연세원주의대, 원광대의대, 인제의대(4건), 인하대의대(3건)
주요 분석 결과 ① 모델 분포	복수 선택 기준 Model 1(통합 로테이션형) 6건, Model 2(지역사회보건 해결형) 6건, Model 3(공공병원 임상몰입형) 5건, Model 4(개원가 중심형) 6건으로 4개 모델 전체에서 실제 운영 사례가 확인됨. 자체 확장 모델(기타) 6건이 함께 제출되어 모형 체계가 현장의 다양성을 수용하면서 확장 가능성을 확인
주요 분석 결과 ② 운영 특성	운영 학년이 예과 1학년부터 의학과 5학년까지 전 학년에 분포하며, 교과 구분은 필수 10건·선택 6건·비교과 2건, 학점 부여 13건으로 정규 교과 편입이 주류를 이룸. 건국대의대(M1~6 나선형 12학점 '지역사회시스템의학')·인하대의대(예과 1학년 '인하와 참의사: 첫걸음1'부터 4학년 특성화선택실습까지)와 같이 나선형·종단형 설계 사례가 확인됨
주요 분석 결과 ③ 특징적 사례	▲가천의대: 인천 일차의료기관 연계 장기추적 통합 임상실습(LIC, 지역의사-교내 지도교수 이중 멘토링) ▲대구가톨릭대의대: 취약계층 주민(독거노인 등)과 학생 1대1 매칭 1년 지속형 실습 ▲인제의대: 재택의료 방문 동행·다직종 멘토링 기반 지역사회실습 ▲인하대의대: 백령병원 등 접경지역 실습(9개 실습지역별 가이드북)과 대만 츠지대 Silent Mentor 국제 연계 ▲원광대의대: 군산의료원 4학년 67명 전원 대상 필수 임상실습 ▲아주의대: 공공병원·보건소·1차 의료기관·협동조합형 의료기관 분산 배치 통합 실습
활용 방법 및 배포 계획	모델별 비교가 가능한 표준 데이터로서 사례집으로 편집·발간(2026. 8.)하고, 2차년도 표준 산출물(가이드북·교육과정안) 집필의 실증 근거 및 신규 도입 대학의 벤치마킹 자료로 활용
한계 및 보완 필요사항	미제출 대학 사례의 추가 수집과 모델 2(예방의학 내재형) 사례의 지속 축적 필요, 운영 성과(학생 평가·만족도) 데이터와의 연계 분석은 2차년도 과제

4. 시범운영 결과

시범운영 대학·대상	해당 없음(1차년도는 개발·컨설팅 단계, 시범운영은 2차년도 추진)
운영 기간·규모	해당 없음
운영 방식	해당 없음
정량 결과	해당 없음
정성 결과	2차 워크숍(모델별 소그룹 토의)에서 참여 대학의 계획안에 대한 퍼실리테이터 피드백·상호 컨설팅을 수행하였으며, 도출된 대학별 실행 계획안은 2차년도 시범운영의 기초자료로 활용
본 과제 산출물에 반영한 사항	워크숍 환류를 반영하여 모델별 워크시트 항목을 가감하고, 모델 2의 사례집 중심 접근 및 모델 4의 실무 사례 축적 방향을 확정함

5. 학술적 성과

연번	제목	유형	학술지·학술대회명	일자·상태
1	지역사회 실습 운영 프로그램 체크리스트 초안 공개	학술대회 발표	KAMC 학술대회	2025. 11. 14. 발표 완료
2	미확정	-	-	-

6. 확산·홍보 실적

구분	내용	대상·규모	일자
성과공유세미나 발표(1회)	과제별 진행 현황·주요 성과 공유 및 질의응답: 통합형 운영 모델 개발 추진 경과, 운영 체크리스트·표준 가이드라인·평가 루브릭 초안 마련, 대학 여건별 적용 가능한 교육과정 모델 정리 현황 발표	의과대학 학장·교수·직원 173명	2026. 2. 6.
성과공유세미나 발표(2회)	'미리보는 의학교육혁신' 지역기반 교육 사례 공유 세션: 부산의대·인하의대·한양의대 교육 사례 소개, 지역사회 연계 의학교육의 확산·적용 전략 논의	165명	2026. 3. 30.
성과공유세미나 발표(3회)	주제별 토포라운드(302호: 지역사회 의학교육·포트폴리오·공유대학): 공통 양식 기반 대학별 교육과정 사례 조사 결과(12개교 18건, 모델별 분포·운영 특성) 공유 및 지역사회 의학교육 운영 경험 논의	123명	2026. 5. 15.
워크숍 개최	전국 실행팀 대상 전체 워크숍 2회(체크리스트·사례 확산, 모델별 컨설팅)	전국 의과대학	2025. 12. 3. / 2026. 3. 6.
리더십 워크숍 연계	학장단·부학장단 대상 4개 모델 소개·질의응답	전국 의대 학장단	2026. 4. 9.~10.
자료 아카이브 게시	체크리스트·워크시트 등 산출물 공동 드라이브 공유	참여 대학	상시

7. 산출물 저작권 및 관리

산출물명	저작권 귀속	공개 범위	관리 주체
표준 체크리스트 v1.0 및 모델별 워크시트	KAMC(개발: 참여 대학 공동)	전국 의과대학	KAMC 사무국·운영팀
운영 모형 정의서·6차원 프레임·산출물 패키지 전략	KAMC(공동)	전국 의과대학	KAMC 사무국·운영팀
대학별 사례 자료	해당 대학(공유 동의 기반)	참여 대학 간 공유	해당 대학·운영팀

06 성과지표 달성도 및 자체평가

1. 성과지표 달성도

연번	성과지표명	목표	실적	달성률	판정 근거·증빙
1	체크리스트 개발	미확정	1종(9개 영역) 완료	-	부록 1, 회의록
2	운영 모형 개발	미확정	4종 정의 확정	-	부록 1, 회의록
3	워크숍·회의 운영	미확정	워크숍 2회, 연구회의 6회, 실무진 회의 12회	-	부록 2(회의록·명단)
4	성과 확산	미확정	세미나 발표 3회, 학술대회 1회	-	부록 6·7
5	협력 기반 구축	미확정	NMC MOU 1건, 정책 제안 4건	-	협약서, 제안서
6	대학별 교육과정 사례 조사	미확정	12개교 18건 수집·분석, 세미나 공유	-	부록 5(사례 원본)

2. 목표 미달·초과 항목 분석

지표	구분(미달/초과)	원인 분석	보완 계획
미확정	-	-	-

3. 자체 평가

잘된 점(강점)	운영팀-실행팀 이원 체계와 전국 단위 워크숍을 통해 산출물을 '개발-공개-환류-확정'의 순환 구조로 완성함. 특히 체크리스트는 운영팀 전원 합의와 전국 실행팀 검토를 거쳐 현장 수용성이 높고, 4개 모델 체계는 12개 대학 18건의 사례 조사에서 모든 모델의 실제 운영이 확인되어 현장 타당성이 검증됨. NMC MOU 등 정책·협력 기반을 조기에 구축함
부족한 점(한계)	1차년도 내 시범운영·정량적 타당화(델파이 등)까지 도달하지 못함. 표준 산출물 4종의 본문 집필은 전략·목차 확정 단계에 머무름. 일부 대학의 워크숍 참여 응답이 저조하여 개별 연락 기반 독려가 필요했음
예상하지 못한 성과	워크숍 방식 전환(소그룹 토의형)을 통해 대학 간 상호 컨설팅 문화가 형성되었고, 실행팀 정기 네트워크 운영 합의 등 자발적 협력 구조가 만들어짐. 리더십 워크숍 연계를 통해 학장단 수준의 실행 동력을 확보함
종합 의견	1차년도 목표인 표준 운영 체계·모형 개발과 확산 기반 구축을 계획대로 달성하였으며, 산출물이 2차년도 시범운영과 표준 산출물 패키지 개발로 직접 승계되는 구조를 갖추

07 성과 확산 및 활용 방안

1. 전국 의과대학 보급·확산 방안

확산 대상	확산 방법	시기	기대 효과
전국 의과대학 실무 교수	체크리스트·워크시트·모형 정의서 아카이브(공동 드라이브) 배포, 정기 네트워크 운영	상시	대학별 교육과정 설계의 공통 기준 확립
학장단·부학장단	리더십 워크숍 모델 소개 세션	2026. 4. 및 연 1회	대학 차원 의사결정·자원 배분 지원
전국 의학교육 공동체	성과공유세미나·KAMC 학술대회 발표, 사례집 발간	연중	우수 사례 확산 및 신규 대학 참여 유도
정부·공공의료기관	정책 제안, NMC 협력 사업(공동 연수·실습기관 Pool)	2026년~	제도·재정 기반의 지속가능성 확보

2. 대학별 적용 사례

□ 공통 양식 기반 사례 조사(12개 대학 18건)를 통해 4개 운영 모형이 실제 대학 교육과정에 적용·운영되고 있음을 확인함(선도 3개 사례의 운영 여건·재정 확보 방식은 표장 4절 참조)

대학명	교육과정(교과목)명	학년·구분·학점	적용 모델	핵심 내용
가천의대	지역사회 의료기관 연계 장기추적 통합 임상실습	의학과 3학년 / 비교과	Model 4	인천 일차의료기관 4곳+가천대길병원 이중 트랙 LIC. 학생 1인당 만성질환·재활 환자 2명 장기추적, 지역의사·교내 지도교수 이중 멘토링, Google Classroom 3자 소통
강원의대	지역보건의료 학생인턴실습	3학년 / 필수 / 2학기 4주	Model 1	도내 5개 의료원·보건소 순환(5개조, 의료원 2곳 2주씩). 의료원 기숙사 활용, 매일 중 DRU(Daily Round Up) 점검, 임상실습 포트폴리오·지도의사 평가
건국의대	지역사회시스템의학	M1~M6 나선형 / 필수 12학점	Model 1·2·3·4 + 기타(CSM Spiral)	의료시스템과학(HSS) 기반 6년 나선형: 이론·지역봉사(M1~2)→지자체·보건소 미니 프로젝트(M3)→공공병원 실습·HSS 토의(M4)→지역사회LIC·현장시스템 IPE(M5)→SDOH 환자 사례분석·발표(M6). 충북도청·충북대와 지역협력거버넌스 체결
경상국립의대	지역사회임상실습(선택의학, 소아청소년과학)	3·4학년 / 선택 2학점	Model 3·4	마산의료원·거창적십자·보훈·창원병원 등에서 대학병원에서 경험하기 어려운 일차진료 참여(소아청소년과 예방접종·발달 평가), 직접관찰·성찰노트 평가
대구가톨릭의대	지역사회의학실습 1·2	2학년 / 필수 2학점 / 1~2학기	기타(주민 1대1 중심형)	보건소 방문보건대상자(독거노인 등 취약계층)와 학생 1대1 매칭 1년 지속 실습. 건강결정요인·의료이용행태·사회보장제도를 주민(환자) 관점에서 이해
동국의대	의학연구설계·예방의학실습 블록 연계과정	1학년 / 필수 1+4학점 / 1~2학기	Model 2	1학기 연구계획서 작성→2학기 예방의학실습 블록에서 지역 건강문제 자료수집·분석·최종보고서까지 수행하는 연계형 연구 교육과정
성균관의대	지역사회진료현장실습	1학년 / 필수 2학점 / 1학기	Model 4 + 기타(조기임상노출)	지역 병원 네트워크·1차의료기관 기반 4주 진료현장실습, 실습일지 기반 성찰활동, KAMC 교육혁신지원사업 연계
순천향의대	지역사회의료기관임상실습	본과 3학년 / 선택 1학점	Model 3·4	천안·서산·홍성의료원 및 순천향대 구미병원 2주 외래 참관 중심 공공의료 경험, 지역의료원 교육프로그램 개발 산출

대학명	교육과정(교과목)명	학년·구분·학점	적용 모델	핵심 내용
인제의대 ①	보건의료체계 접근을 통한 지역 사회 사정	예과 2학년 / 선택	Model 2	지역보건의료체계(DHS) 데이터 수집·분석으로 지역건강프로파일 작성 및 정책브리프 제안, 부산 반송 건강마을사업 현장 실습
인제의대 ②	사회와 건강·(선택학습)지역사회 보건의료정책	본과 1학년 / 선택	Model 2	지역보건의료정책·재택의료 강의와 외부 특강, '부산시의 건강 책임' 조별 과제로 지역 건강문제 옹호자(Advocator) 역량 함양
인제의대 ③	좋은의사되기	예과 1학년 / 필수 2학점	기타(지역사회연계 PBL)	김해·부산 지역사회 문제 발굴형 프로젝트 수업(약 100명, 16~17개조). 자료수집·전략기획·지역활동·포스터 발표, 포트폴리오·동료평가
인제의대 ④	지역사회실습	3학년 / 필수 1학점 / 2주 중 1주	Model 1	재택의료 방문 동행(의사·간호사·사회복지사 주도 3개 팀), 다직종사례회의의 참관·발표, 서사의학 심층 인터뷰, 루브릭·360도(간호사) 평가. 돌봄통합지원법 시행 대응
인하의대 ①	특성화선택실습(대만 츠지대학교 Silent Mentor)	4학년 / 선택 4학점 / 1주	기타(CBME 확장 국제연계)	시신 기증자·유가족·지역 의료기관이 참여하는 해부학·임상술기·의료인문학·성찰 통합교육. 츠지대와 국제 교육협력체계 MOU 추진
인하의대 ②	특성화선택실습(백령병원)	4학년 / 선택 4학점 / 3차수	Model 1·2·3·4	접경 도서지역 백령병원 상주형 임상실습(초진환자 예진·응급실 실습·주민 보건교육·지역사회현황분석). 9개 특성화선택 실습지역별 가이드북(매뉴얼) 개발, 전임교수 현장 상주
인하의대 ③	인하와 참의사: 첫걸음 1	예과 1학년 / 필수 3학점	Model 2 + 기타(학생참여형 통합교육)	교육청·국가정보원·백령병원·평화교육원·고등학교와 협력한 다학제 통합교육. 강화 교동도 1박 2일 현장 프로그램, 고교생 금연교육 기획·운영, 졸업성과 연계 학습포트폴리오

※ 사례별 상세 내용(선택 이유, 실습/학습 구조, 평가 방법, 필요 지원 등)은 공통 양식 원본으로 부록 5에 수록함

3. KAMC 플랫폼·타 과제 연계 방안

- 공유대학(K-MedU) 시스템과 연계한 학점 공유 체계 및 전국 실습지 학생 선택형 매칭 시스템 개발을 추진하고, 지역 코디네이터 지정·중앙-현장 연결 구조를 설계함
- 임상실습 포트폴리오·LIC·IPE 과제와 학습경험·평가 설계를 상호 반영하고, 성과관리 체계 구축 과제와 공통 성과지표(2026년 Pilot)를 연동함

4. 지속 가능성 확보 방안

- 운영 주체 및 관리 체계: KAMC(중앙 표준·아카이브 관리) – 권역(컨소시엄·NMC 연계 실습기관 Pool) – 대학(교과 반영·운영)의 3층 관리 체계
- 갱신·고도화 주기: 체크리스트·워크시트는 연 1회 워크숍 환류를 반영하여 개정, 모형 정의서는 사례 축적에 따라 버전 관리

08 추진 과정의 쟁점·애로사항 및 개선 방안

구분	쟁점·애로사항	원인	대응 및 개선 제안
현장 운영	지역 실습 인프라(숙소·이동·수용역량) 부족과 실습기관의 소극적 태도	교육 참여에 대한 기관 유인 부재	체크리스트에 생활지원·안전관리 요건 명시, 기관 성과평가 교육 참여 지표 반영 등 외적 동기부여 제안
인력·보상	지도 의료진·지도교수에 대한 보상·지원책 미비	교육 활동에 대한 인정·보상 체계 부재	지도의사 수당(동국대), 기관 지원비(부울경) 등 사례 확산, '지도교수 부담 최소화 평가도구' 공동 개발

09 지역사회 실습 운영 체크리스트 개발 결과

지역사회 실습을 준비하는 교수와 행정 담당자가 기반 조성부터 학생 안전관리까지 점검할 수 있도록 표준 체크리스트 v1.0을 개발했습니다. 대학별 여건에 맞게 항목을 가감하고, 모형별 워크시트와 연결하여 활용합니다.

지역사회 실습 운영 체크리스트의 9개 핵심 영역실습 기반 조성 → 실습 운영 → 학생 지원으로 이어지는 공통 점검 체계입니다.

1. 실습기반 조성 I : 지역자원 개발 참여기관 섭외 및 협조체계 구축	2. 실습기반 조성 II : 연계체계 구축 권역별 대학 연합 효율적 운영	3. 실습기반 조성 III: 의료진 및 담당자 참여 외적/내적 동기부여 통한 참여 제고
4. 실습 운영 방향 지침서 개발 및 의료진 교육	5. 교과목 운영 방향 필수/선택 교과목 지정 및 학점 부여	6. 실습 운영 방안 임상/지역사회 경험 체계적 제공
7. 학생 생활지원 방안 기숙사/숙박지원 통한 안정적 환경	8. 학생 모니터링 방안 출석관리 및 정기 피드백 체계	9. 학생 안전관리 방안 안전규정, 보험, 사전교육 실시

그림 크게 보기 ↗

체크리스트 개발·공유 과정

- 2025.10초안 작성과 운영팀 전원 검토·동의
- 2025.11학술대회 공개와 의견 수렴
- 2025.12전국 실행팀 워크숍 검토·환류
- v1.0 확정9개 영역의 공통 점검 체계 완성
- 2026.02-03모형별 엑셀 워크시트 확장·워크숍 적용

1차년도에는 합의와 현장 검토를 거쳐 체크리스트 v1.0을 확정·공유했습니다. 항목별 중요도와 실행가능성의 정량적 검증은 후속 시범운영에서 보완합니다.

영역별 점검 내용

01

실습 기반

지역자원 개발

참여 가능한 기관과 협조체계를 확보하는 영역입니다. 지역의 보건·의료기관과 관계자를 파악하고 실습자원으로 연결합니다.

02

실습 기반

연계체계 구축

대학과 기관의 협력 관계를 구조화하는 영역입니다. 권역별 대학 연합과 기관 간 역할 분담을 통해 실습을 지속적으로 운영할 기반을 마련합니다.

03

실습 기반

의료진·담당자 참여

현장 의료진과 담당자의 교육 참여를 확보하는 영역입니다. 담당 역할과 협조체계를 명확하게 하고, 참여를 지속할 수 있는 여건을 점검합니다.

04

실습 운영

실습 운영 방향

지역의 건강문제와 임상 경험 중 어떤 교육적 가치를 중심에 둘지 정하는 영역입니다. 대학의 교육목표와 현장의 특성을 연결합니다.

05

실습 운영

교과목 운영 방향

필수·선택 교과목 여부와 학점 등 학사 구조를 정하는 영역입니다. 지역사회 경험이 정규 교육과정 안에서 어떻게 인정되는지 설계합니다.

06

실습 운영

실습 운영 방안

학습목표, 활동, 과제, 평가를 실제 운영 지침으로 연결하는 영역입니다. 학생과 지도자를 위한 안내, 지도·피드백 체계를 함께 준비합니다.

07

학생 지원

학생 생활지원

숙박과 이동 등 안정적으로 참여할 수 있는 생활 여건을 점검하는 영역입니다. 실습 장소가 달라져도 학생의 학습이 이어지도록 지원합니다.

08

학생 지원

학생 모니터링

출석과 학습 진행 상황을 확인하고 정기적으로 피드백하는 영역입니다. 실습 중 어려움을 파악하여 대학과 현장이 함께 대응합니다.

09

학생 지원

학생 안전관리

보험과 위험관리를 포함해 안전한 참여 조건을 점검하는 영역입니다. 사전 안내와 안전관리 체계를 실습 운영에 포함합니다.

현장 적용 방식

대학과 실습기관이 함께 운영 여건을 확인하고, 교육목표에 맞춰 점검 항목을 조정합니다. 모델별 워크시트에 담당 역할과 보완 사항을 정리한 뒤, 워크숍과 현장 피드백을 통해 개선하는 구조입니다.

10 교육과정 운영 모형·그림과 설계 기준

대학별 지역 여건과 교육목표에 따라 선택하거나 혼합할 수 있는 네 가지 운영 모형을 개발했습니다. 사례 분석을 바탕으로 유형을 정리하고, 개원가 중심형을 더해 네 가지 체계를 확정한 뒤 모형별 컨설팅에 적용했습니다.

지역사회기반 교육과정 운영 모형 비교네 가지 모형을 핵심 포커스, 실습장 구성, 주요 학습경험, 대표 산출물, 운영 포인트로 비교합니다.

구분 / 모델	Model 01 지역기반 통합 로테이션형	Model 02 지역사회보건 건강문제 해결형	Model 03 지역공공병원 임상몰입형	Model 04 지역사회 개원가 (일차의료) 중심형
 핵심 포커스	지역·임상 통합 경험 연속성 확보	건강문제 분석 및 보건기획 역량	공공병원 환경 일차진료 임상역량	지역 개원가 현장의 일차의료 경험
 실습장 구성	복합형 의료원 + 보건소 + 지역기관 순환	지역사회형 보건소 / 지자체 유관기관 중심	병원중심형 공공병원 / 의료원 단일 또는 병원군	개원가형 지역 개원의원 + 2차병원 협력
 주요 학습경험	외래/병동 + 지역사회 기관 간 연계 사례관리	지역통계 분석, 방문 보건사업 기획	외래·병동·응급실 팀 기반 진료(IP)	만성질환 관리, 상담 의뢰-회송 체계 이해
 대표 산출물	필수경험 체크리스트 연속성 포트폴리오	지역건강 진단보고서 보건기획안	환자 케이스 로그 Mini-CEX 평가	외래 케이스 로그 일차진료 성찰일지
 운영 포인트	이동·숙소 지원체계 전담 코디네이터	지자체 협력 거버넌스 지역 멘토단 운영	병원 수용역량 확보 지도전문의 인센티브	개원의 협력 네트워크 소규모 그룹 순환

* 각 모형은 대학별 지역 여건에 교육 목표에 따라 유연하게 적용할 것을 권고합니다.

그림 크게 보기 ↗

MODEL 01

지역기반 통합 로테이션형

지역·임상 통합 경험과 연속성을 중심으로 설계합니다.

실습 현장

의료원·보건소·지역기관을 순환

학습 경험

외래·병동과 지역사업, 기관 간 연계 사례관리

학생 산출물

필수경험 체크리스트·연속성 포트폴리오

운영의 핵심

기관 간 연결, 이동·생활 지원, 전담 코디네이터

MODEL 02

지역사회보건·건강문제 해결형

건강문제 분석과 보건기획 역량을 중심으로 설계합니다.

실습 현장

보건소·지자체·유관기관 중심

학습 경험

지역 통계 분석, 방문, 보건사업 기획

학생 산출물

지역건강 진단보고서·보건기획안

운영의 핵심

지자체 협력과 지역 멘토단

MODEL 03

지역공공병원 임상몰입형

공공병원 환경의 일차진료 임상역량을 중심으로 설계합니다.

실습 현장

공공병원·의료원 단일 기관 또는 병원군

학습 경험

외래·병동·응급실, 팀 기반 진료

학생 산출물

환자 사례 기록·Mini-CEX 평가

운영의 핵심

병원의 수용역량과 지도체계

MODEL 04

지역사회 개원가(일차의료) 중심형

지역 개원가의 일차의료 경험을 중심으로 설계합니다.

실습 현장

지역 개원의원과 2차병원 협력

학습 경험

만성질환 관리·상담, 의뢰·회송 체계 이해

학생 산출물

외래 사례 기록·일차진료 성찰일지

운영의 핵심

개원의 협력 네트워크와 소규모 그룹 순환

교육과정 운영 모형의 6차원 설계 틀교육목표, 실습장 구성, 핵심 학습경험, 학생 산출물, 평가체계, 운영·지원 요건을 함께 검토합니다.

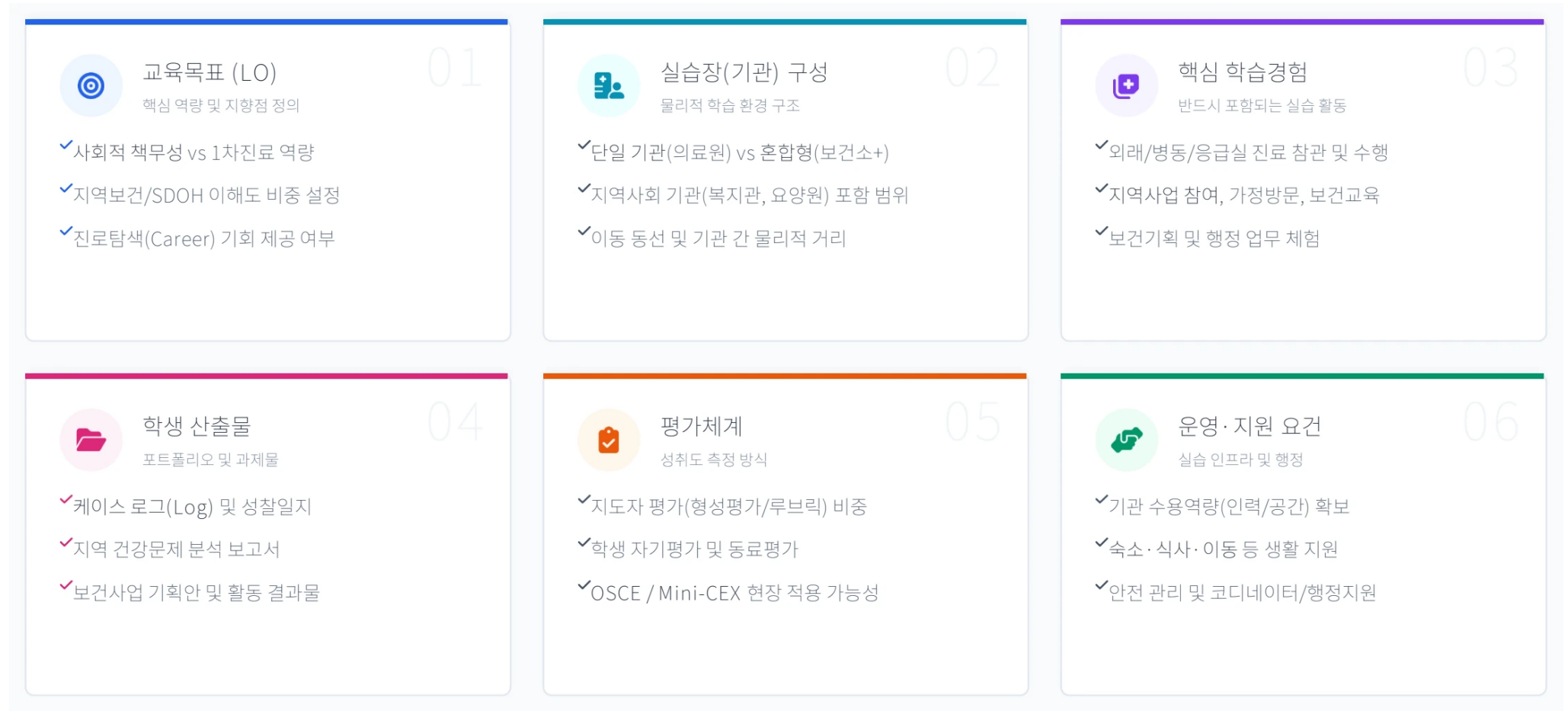


그림 크게 보기 ↗

설계 항목	검토 내용
교육목표(LO)	사회적 책무성·일차진료 역량, 지역보건 이해, 진료탐색의 비중
실습장 구성	단일 기관·복합 기관, 지역사회 기관의 참여 범위, 기관 간 이동
핵심 학습경험	임상 진료, 지역사회·가정방문·보건교육, 보건기획 경험
학생 산출물	사례 기록과 성찰일지, 지역 건강문제 분석, 보건사업 기획·활동 결과
평가체계	지도자 평가·루브릭, 자기·동료평가, OSCE·Mini-CEX 적용 가능성
운영·지원 요건	수용역량, 생활 지원, 안전관리와 코디네이터·행정지원

지역사회기반 교육 프로그램의 유형봉사중심·연구중심·훈련중심의 교육 접근을 구분한 개념도입니다. 네 가지 현장 운영 모형과 함께 설계의 방향을 이해하는 데 활용합니다.



그림 크게 보기 ↗

봉사·연구·훈련은 교육 접근의 분류이며, 네 가지 모형은 현장 구성과 운영 방식의 분류입니다. 지역 여건과 교육목표에 따라 여러 접근과 모형을 함께 적용할 수 있습니다.

2차년도·후속 방향

학생·교수 가이드북, 교육과정안, 교수개발 프로그램의 표준 패키지 4종을 완성하고, 대학별 모형 적용과 공통 성과지표 시범운영을 추진합니다. 사례집 축적, 실습기관 매칭, 공유대학 연계 학점 공유도 구체화합니다.